나비웹 의사 컨소시엄 참여 제안서 (초안)

대상: 의원·병원 개설 의사(의료기관 개설자) · 소속 의사(봉직의)

2026-10-18 · 나비 개발자 대표 도영민 · hondi.net

> **초안 안내** 본 문건은 **초안**이며, **예고 없이 변경될 수 있습니다.** 컨소시엄 참여자(개인·법인)가 확정된 후에 **정식 문서를 확정**합니다. 정식 문서가 확정되기 전에는 이 문건의 어떤 내용도 확정된 약속이 아닙니다.
>
> 협약과 법인 구조의 구체적인 내용은 법률·회계 검토와 직역 단체 협의를 거쳐 확정하며, 확정되지 않은 항목은 "미확정"으로 표시했습니다. **이 제안에는 출자금이 따르므로, 특히 7장(출자·수입·로열티)과 8장(투자 위험)을 먼저 읽어 주십시오.** 말미의 17장(면책 조항)도 함께 확인해 주십시오.

---

1. 제안 요약

의사 여러분께, 나비웹 기반 의사 업무 보조 AI 서비스를 함께 출자해 보급하는 **컨소시엄**에 참여하실 것을 제안드립니다.

- **무엇을 하나요**: 참여 의료기관들이 자본금을 출자해 **주식회사 형태의 컨소시엄 법인(가칭)** 을 설립합니다. 법인은 의사 업무 보조 AI 서비스를 기존 의사와 의료기관 직원에게 소프트웨어(SaaS)로 보급해 수입을 올리고, **나비웹에 AI 모델 이용료 또는 로열티를 지급**합니다.
- **특이 사항**: 법인은 납입된 출자금으로 **1년치 추정 로열티를 나비웹에 선지급**하며, 이 금액은 나비웹의 **국산 LLM 서버 구축 비용 중 일부**로 쓰입니다. 선지급액은 사실상 사업 초기에 나비웹의 인프라 구축을 함께 부담하는 성격이므로 8장에서 위험과 보호 장치를 자세히 설명합니다.
- **달라지지 않는 것**: 진단·처방·치료와 그 판단, 문서의 확정과 서명은 모두 **참여 의료기관의 의사가 자기 이름과 책임으로** 합니다. AI는 진단·처방·치료를 하지 않으며,

서명·날인·접수·제출·대리를 하지 않습니다. 컨소시엄 법인은 **의료행위를 수행하지 않으며**, 의료행위로 오인될 표시·광고를 하지 않습니다.

- **요청드리는 것**: ① 출자 참여 검토, ② 법인 지배구조와 이용 기준 제정에 의견 제시, ③ (선택) 동료 의사에게 사용 경험 공유.

---

2. 나비와 나비웹

나비(NAVI)는 "나만의 AI 비서"이고, 나비웹(naviweb)은 그 나비들이 모여 사람·AI와 소통하는 메신저형 플랫폼입니다. 이용자는 대화창에서 요청하고, 나비가 업무를 진행합니다.

- 이용자의 정보는 **본인의 데이터 금고(PDV)에만 저장되고 서버에는 저장되지 않습니다.**
- 광고 없는 비영리 구조이며, 소스코드는 GPL v3.0으로 공개되어 있습니다.
- 나비의 AI는 A.X 4.0을 바탕으로 분야별로 나눈 소형 모델을 골라 쓰는 방식(MoTE)이며, 해외 LLM으로 이용자 정보가 이전되지 않도록 국산 자체 모델 체계를 만드는 중입니다. 이 제안의 서버 구축 비용 분담은 이 체계에 쓰입니다.
- 전문가용 업무 보조 AI는 직업군 63개, 세부 분야까지 140여 개 페이지로 구성되어 있고, 그중 **의사 업무 보조 AI**가 이번 제안의 대상입니다.

---

3. 나비웹이 하는 일, 의사가 하는 일

단계	담당	내용
작성·정리	나비 (관련 SP)	진료와 관련된 문서의 초안 작성, 문헌 검색, 설명문 작성
점검	나비 (관련 SP)	서류 사이의 모순, 필수 항목의 누락, 법령 근거를 점검하고, 문제가 있으면 사유를 알림

단계	담당	내용
위변조 방지	Openhash	누가 언제 작성·승인했고 이후 바뀌지 않았다는 사실을 보장
판단·확정·승인·대리	**의사**	진단·처방·치료와 그 판단, 문서의 확정과 서명

나비가 만든 모든 결과물은 의사가 승인하기 전까지 **"초안·미확정"** 입니다. 연결되지 않은 데이터는 추정으로 채우지 않고 "미연동"으로 표시합니다.

현재 단계: 의사 페이지의 의료법·시행규칙 서식 번호·보존기간·감염병 신고 서식은 정리본(요약·해설 자료) 기준이며 법제처 원문과 대조하지 않았습니다. 실제 업무와의 연동은 13장의 사전 조건을 마친 뒤 시작합니다.

---

4. 신뢰 구조와 그 한계

나비웹은 세 겹의 장치로 업무의 신뢰를 높이도록 설계되어 있습니다.

1. **자동 작성**: 사람이 입력하다 생기는 누락과 오류를 줄이도록, 관련 SP가 같은 절차로 처리합니다.
2. **점검 단계**: 관련 SP가 법령 근거, 필수 항목, 서류 사이의 정합성을 점검하고 문제가 있으면 사유를 알립니다.
3. **불변 기록**: Openhash가 사후 변조를 막아, 작성과 승인의 이력이 사실대로 남도록 합니다.

다만 다음 한계를 분명히 말씀드립니다.

- Openhash가 증명하는 것은 **무결성**입니다. 기록 내용이 사실인지까지 보장하지는 않습니다.
- SP의 점검은 입력된 정보와 설계된 기준에 한정됩니다. 입력되지 않은 사실관계는 알 수 없습니다.

- SP도 판단을 잘못할 수 있습니다. 잘못된 지적을 하거나 놓칠 수 있으며, 그래서 **최종 판단은 의사의 몫**입니다. 지적한 항목에는 사유를 알리고, 이의를 제기할 절차를 둡니다.

---

5. 참여 의료기관에 기대되는 것

아래는 설계상 기대하는 효과이며, **업무 시간 감소율이나 수익 수치는 운영 실측 전에는 말씀드리지 않겠습니다.**

- 진료 문서 초안과 설명문 작성, 문헌 검색에 드는 반복 작업을 줄일 수 있는 도구
- **AI 작성분과 의사의 검토·수정·승인을 구분한 이력**: 어떤 검토를 거쳐 확정했는지 보여 주는 자료로 쓰이도록 설계했습니다.
- 기록의 무결성 증명: 분쟁이나 점검 때 참고할 수 있는 자료
- 법인의 주주로서 서비스 방향, 요금, 이용 기준을 함께 결정할 권리
- 이익이 생길 경우 보유 주식 수에 비례한 배당 (**보장되지 않으며 손실이 날 수도 있습니다**, 8장 참고)

---

6. 컨소시엄 구성과 역할

구성원	주요 업무	유의 사항
의원·병원 개설 의사 (의료기관 개설자)	문서 초안 작성, 문헌 검색, 설명문 작성	의료기관 개설 제한과 의료광고 규제를 받습니다(의료법 제33조 등, 확인 필요)
소속 의사(봉직의)	문서 초안 작성, 문헌 검색, 설명문 작성	진단·처방과 그 판단은 의사가 직접 합니다

- 직역별 업무 범위는 **법령 그대로** 따릅니다. 컨소시엄은 범위를 넓히거나 조정하지 않으며, 협약서의 업무 경계도 법령 문구로 적습니다.

- 서비스는 의사의 문서 초안, 문헌 검색, 설명문 작성을 보조하는 도구에 그쳐야 하고, 진단·처방의 판단과 책임은 의사에게 있어야 합니다(의료법 제27조). **환자가 직접 이용하는 구조는 쓰지 않습니다.**
- 진단·치료 목적의 소프트웨어는 의료기기 허가 대상이 될 수 있어, 기능 범위를 문서 보조로 제한하고 허가 필요 여부를 확인합니다.
- 컨소시엄 법인은 의료기관이 아닙니다. 의료기관 개설 제한(제33조)과 의료광고 규제에 걸리지 않도록 명칭과 홍보 문구를 정합니다.
- 환자 정보는 개인정보 보호법상 민감정보이고 의료법에 비밀 유지·기록 열람 규정(제19조·제21조, 확인 필요)이 있습니다. **환자 식별 정보를 서버에 올리지 않는 이용 원칙**과 보안 인증을 확인합니다.

---

7. 컨소시엄 법인: 출자, 수입, 로열티

7.1 법인의 성격

- 컨소시엄 법인은 상법에 따른 **주식회사**로 설립합니다. 상호(가칭), 소재지, 자본금은 미확정입니다.
- 주주는 자신이 인수한 주식의 금액 한도에서만 책임을 집니다(유한책임).
- 사업 목적은 **소프트웨어·SaaS의 보급, 교육, 이용 지원**입니다. 법인은 의료행위를 하지 않으며, 의료기관이 아닙니다. 의사 업무는 계속해서 각 의료기관이 환자와 개별 계약해 자신의 책임으로 수행합니다.

7.2 출자와 주식 (미확정)

이 문서에서 **출자자**는 주식을 인수하는 의료기관(설립 후에는 주주)를 뜻합니다.

- 참여 의료기관이 주식을 인수해 출자하고, 보유 주식 수에 따라 의결권과 배당을 받습니다.

- 상법상 주식회사에는 최소 자본금 요건이 없습니다. 다만 **선지급, 서버 비용 분담, 운영비를 감당할 수 있는 금액**으로 자본금을 정해야 하며, 총액과 의료기관별 인수 한도는 **미확정**입니다.
- **지배 방지**: 주식회사의 의결권은 1주 1표가 원칙이므로, 특정 의료기관이 법인을 지배하지 못하게 하려면 ① 의료기관별 주식 인수 한도, ② 정관상 주식 양도 제한(이사회 승인), ③ 중요 사항의 가중 결의 요건, ④ 주주 간 계약을 함께 쓰는 방안을 검토합니다. 구성원 수를 기준으로 의결하는 방식(구성원당 1표)은 상법의 원칙과 달라 구현 가능성을 법률 검토로 확인합니다.
- 주식 인수 자격은 의사 자격을 확인받은 의료기관이며, 자격 요건을 갖추면 누구나 참여할 수 있게 엽니다.
- 의사 개인과 의료기관 등 법인·기관이 이 주식회사의 주식을 취득하는 것이 법령상 허용되는지, 어떤 신고나 제한이 따르는지는 확인 중입니다(13장).
- 배당은 상법상 배당가능이익의 범위 안에서 **보유 주식 수에 비례**해 이루어집니다.

7.3 법인의 수입 (미확정)

- **판매 대상**: 기존 의사와 의료기관 직원
- **수입원**: 이용자 요금(구독료 + 사용량 종량 요금), 교육·구축 용역
- **이용자 요금의 틀**: 의사와 의료기관 직원 각각 연 99,000원이 기본이고, 사용량에 따른 종량제 추가 요금이 붙습니다. **요금을 징수하는 주체와 정산 방식, 종량 단가는 미확정**이며 런칭 전에 협약서에 명시합니다.
- **이용 범위의 한계**: 이 서비스는 의사와 의료기관 직원이 쓰는 **업무 보조 도구**입니다. **환자가 직접 이용해 의사 업무를 받는 구조는 쓰지 않습니다.**

7.4 나비웹에 지급하는 이용료·로열티 (미확정)

- 법인은 나비웹의 AI 모델과 서비스를 쓰는 대가로 **AI 모델 이용료 또는 로열티**를 나비웹에 지급합니다.
- 산정 기준(사용량 연동 이용료인지, 매출 연동 로열티인지), 요율, 최저 보장액은 **미확정**이며, 협약서에 명시하기 전에 출자자에게 산출 근거를 모두 공개합니다.

- 소스코드가 GPL v3.0으로 공개되어 있으므로, 대가는 소스코드 자체가 아니라 **AI 모델 추론·호스팅·지원 서비스**에 부과하는 구조로 설계합니다. GPL v3.0은 부여된 권리의 행사에 사용료를 받는 것을 제한할 수 있으므로 이 설계는 법률 검토가 필요합니다. 모델의 바탕이 된 원 모델의 라이선스 조건도 확인합니다(13장).

7.5 1년치 추정 로열티 선지급

법인은 납입된 출자금(현금)으로 **1년치 추정 로열티를 나비웹에 선지급**합니다. 이 금액은 나비웹이 국산 LLM 서버를 구축하는 비용의 일부로 쓰입니다. 선지급액의 성격이 모호하면 출자자의 권리가 불분명해지므로 다음 원칙을 제안합니다. (모두 미확정이며 협약서에서 확정합니다.)

항목	제안
선지급액 산정	1차 연도 예상 사용량(또는 예상 매출) × 계약 요율. 산정 가정과 근거를 출자자에게 공개하고, 출자자 의결로 확정
회계 처리	납입된 출자금(현금)이 선급 비용(선급 로열티)이라는 자산으로 바뀌며, 등기된 자본금 자체는 변하지 않습니다. 실제 사용량·매출에 따라 비용으로 차감하고, 비용 처리 시점과 금액을 투명하게 보고
정산	실제 발생액이 선지급액보다 적으면 남은 금액의 이월 또는 반환, 많으면 추가 지급. 정산 방식은 협약서에 명시
사용처 공개	서버 구축에 쓰인 금액, 내역, 진행 상황을 출자자에게 정기적으로 공개하고, 출자자가 요청하면 독립적인 검토(감사)를 받습니다
서버 구축 지연·미이행	마일스톤(구축 단계와 시기)을 협약서에 명시하고, 미달하면 선지급액의 조정 또는 반환 조건을 둡니다
출자자의 권리	서버 구축 비용을 분담하는 대가로 출자자에게 돌아가는 권리(예: 이용료·로열티 요율의 우대, 우선 이용 등)를 협약서에 명시
이해관계 공개	나비 개발팀은 선지급을 받는 공급자이므로, 나비웹과 법인 간 계약은 **이해관계가 있는 거래**로 보고 개발팀의 이해관계를 공개하며, 출자자 의결 또는 독립 검토를 거칩니다

8. 투자 위험: 출자하기 전에 알아야 할 점

- **손실 가능성**: 출자금은 사업이 부진하면 일부 또는 전부를 잃을 수 있습니다. 이익을 약속하지 않으며, 수입과 이익에 대한 전망 수치는 이 문서에 넣지 않았습니다.
- **선지급 회수 위험**: 선지급액이 서버 구축에 쓰이는 만큼, 구축이 지연되거나 이루어지지 않을 경우의 반환과 정산 조건이 협약서로 보장되어야 합니다. 이 조건이 확정되기 전에는 출자를 요청하지 않습니다.
- **공급자 의존**: 법인의 서비스는 나비웹의 AI와 서비스에 의존합니다. 나비웹의 사정이 법인의 사업에 영향을 줄 수 있습니다.
- **이해관계 구조**: 나비 개발팀은 공급자이면서 간사입니다. 7.5절의 공개와 의결 절차로 이 구조를 관리하겠지만, 이해가 상충할 가능성이 있다는 점은 분명합니다.
- **법령 변경과 해석**: 직역법의 적용, 공정거래법상 공동사업 검토, 광고·소개 규정의 해석에 따라 법인 구조가 바뀔 수 있습니다.
- **직역 단체의 입장**: 대한의사협회와의 협의 결과에 따라 사업 방식이 달라질 수 있습니다.
- **사업 구조상의 한계**: 나비웹은 비영리 구조를 표방합니다. 선지급과 로열티 수령이 이 구조와 어떻게 정합되는지는 협약서에서 설명하고 확정합니다(13장).
- **환금성**: 비상장 주식이므로 팔기 어렵고, 양도는 정관에 따라 제한될 수 있습니다.
- **지분 희석**: 증자로 신주가 발행되면 지분율이 낮아질 수 있습니다. 주주 간 계약으로 보호 방안을 검토합니다.
- **주식 발행 방식**: 청약을 권유받는 사람의 수 등에 따라 자본시장법상 증권신고 의무가 생길 수 있습니다. 발행 방식과 규모를 법률 검토로 확인합니다(확인 필요).
- **시장 규모의 불확실성**: 전파 대상 규모는 근사치이며 직접 확인하지 못한 수치가 포함되어 있습니다(11장).
- **건강정보 위험**: 환자 식별 정보가 서비스에 입력되면 개인정보 사고의 영향이 큽니다. 입력 금지 원칙, 비식별 처리, 사고 대응 절차를 먼저 마련해야 합니다.

---

9. 운영 원칙

9.1 의사결정

- **주주총회**가 정관, 증자, 이사 선임, 배당을 의결하고, **이사회**가 요율, 선지급, 서버 비용 분담 같은 주요 업무를 의결합니다. 나비웹과의 계약처럼 이해관계가 있는 사안은 주주총회의 승인을 받는 방안을 검토합니다.
- 나비 개발팀 소속자는 이사·감사가 되지 않는 방안을 검토합니다(이해충돌 방지).
- **운영위원회**(이사회 산하): 구성원 유형별로 각 1인 이상 참여해 서비스 운영 기준과 분쟁을 다룹니다.
- **품질·윤리위원회**: 승인 한도, 승인 기록, 홍보 규칙의 준수를 점검합니다.
- **직역 단체 협의**: 대한의사협회에 이 구상을 설명하고 협의하겠습니다. 협의 결과는 확정되는 대로 공개합니다.
- 나비 개발팀은 간사로서 의결권이 없으며, 나비웹과 법인의 계약에는 개발팀이 의결에 참여하지 않습니다.

9.2 공정한 경쟁

경쟁 관계의 의료기관들이 함께 출자하는 만큼 다음을 원칙으로 합니다.

- **의사 업무의 진료 관련 대가와 가격은 각 의료기관이 독립적으로 정합니다.** 법인과 컨소시엄은 의료기관의 진료 관련 대가 기준, 할인, 최저가를 정하지 않습니다. (법인이 정하는 것은 **소프트웨어 이용 요금**에 한정됩니다.)
- 환자·지역·업종을 나누지 않습니다.
- 의료기관 간 **환자 정보와 진료 관련 대가 정보를 교환하지 않습니다.** 각 의료기관의 데이터는 서로 격리되어 있어 다른 의료기관의 데이터를 볼 수 없고, 법인과 나비 개발팀도 열람하지 않도록 설계합니다.
- 배당은 **보유 주식 수에 비례**하며, 소개 실적이나 판매 실적과 연동하지 않습니다.
- **가입은 열려 있습니다.** 자격을 확인하고 협약에 동의하는 의료기관라면 누구나 참여할 수 있습니다.

9.3 환자 연결

- 기본은 **참여 의료기관이 기존 환자를 직접 초대**하는 방식입니다. 나비웹이나 법인이 환자를 특정 의료기관에 보내지 않습니다.
- 컨소시엄 법인이 의사에게 환자를 소개하거나 진료 수입을 나누는 구조는 쓰지 않습니다(의료법 제27조 제3항, 확인 필요).
- 신규 이용자가 전문가를 찾는 기능은 알선·광고 규정에 저촉되지 않는지 **법률 검토를 마친 뒤에** 엽니다. 열더라도 지역·직역·업종 필터와 중립적인 정렬만 쓰고, 유료 우선 노출과 성과 수수료는 두지 않습니다.
- 의료기관 사이의 업무 의뢰는 자유롭지만, **의뢰나 소개의 대가로 수수료를 주고받지 않습니다.**

---

10. 참여 조건 (협약 핵심 조항, 미확정)

1. **자격 확인**: 의사 면허·등록(자격)을 확인받고, 직무정지 등 결격 여부를 제출합니다.
2. **주식 인수와 주주 간 계약**: 인수 주식, 의결, 배당, 주식 양도·회수 조건은 정관과 주주간 계약에 따릅니다.
3. **승인 한도**: 의사 1인이 실제로 검토·승인할 수 있는 업무량의 한도를 정하고, 한도에 이르면 신규 연동을 받지 않습니다. 한도의 수치는 이 직역의 업무 특성에 맞춰 초기 운영의 실측 후 확정합니다(미확정).
4. **승인 이력 기록**: AI 작성분과 의사의 검토·수정·승인을 구분해 Openhash에 남깁니다. 실질적인 검토 없이 서명만 하는 일을 막고, 책임 소재를 분명히 하기 위함입니다. 이 원칙은 법인이 판매하는 서비스의 이용 약관에도 적용합니다.
5. **홍보 규칙**: 11장의 규칙을 지킵니다.
6. **환자 정보**: 환자 식별 정보는 서비스에 입력하지 않는 것을 원칙으로 하고, 이용 약관과 화면에 이를 명시합니다.
7. **직역법 확인**: 의료법상 이 법인의 주주 자격과 의료인의 임원 겸직 제한, 환자 유인·알선 규정(제27조 제3항)을 법률 전문가가 확인합니다.

8. **독립 가격·고객**: 9.2절의 원칙을 지킵니다.
9. **책임보험**: 업무배상책임 보험·공제를 유지합니다(의무와 한도는 확인 필요).
10. **비밀·개인정보**: 이용자가 동의한 범위 안에서만 열람하고, 열람 이력을 남깁니다.
11. **직원 계정**: 구독은 개인 단위입니다. 의료기관 직원도 각자 계정을 두며, 소속 의사가 등록하고 감독합니다. 직원 계정은 서류 준비와 자료 정리만 할 수 있고, **승인·확정·서명·제출 권한은 없습니다.**

---

11. 서비스를 알리는 일

컨소시엄 법인이 서비스를 알리는 일은 법인의 사업입니다. 출자자인 참여 의료기관이 동료 의사에게 사용 경험을 나누는 것은 **선택이며, 의무도 참여 조건도 아닙니다.**

- **전파 대상 규모(참고)**: 활동 의사 약 118,000명(2023년 기준 보건의료 면허·자격자 통계 보도: 의사 면허자 12만 8천 명 중 활동 11만 8천 명, 92.1%). 개원의·봉직의 구분과 최신 연도는 확인하지 못했습니다. 이 수치는 근사치이며 참여 규모를 약속하는 것이 아닙니다.
- **주주라는 사실과 이해관계를 밝혀 주십시오.** 주주가 서비스를 권하는 것은 이해관계가 있는 소개이므로, 반드시 **컨소시엄 법인의 주주라는 사실**을 밝혀 주십시오.
- **소개의 대가는 없습니다.** 가입을 소개하는 대가로 금전, 수수료, 수당, 할인을 드리지 않으며, 소개 실적을 평가하지도 않습니다. 배당은 보유 주식 수에 비례할 뿐 소개·판매 실적과 무관합니다.
- 근거 없는 단정이나 수치를 쓰지 마십시오. "업무량 N% 감소" 같은 표현은 삼가 주시고, 법인이 공개하는 실측 결과로 말씀해 주십시오. 의료광고 규제는 확인하지 못했습니다(확인 필요). 컨소시엄 법인은 의료기관이 아니며, 치료 효과를 암시하는 표현을 쓰지 않습니다.
- **의료행위로 오인될 표시를 쓰지 마십시오.** 법인과 서비스는 의료행위를 수행하지 않습니다. "나비 인증 의사"처럼 공식 자격이나 인증으로 오인될 표시도 쓰지 마시고, 표기는 **"나비웹 이용 의료기관"** 로 통일해 주십시오.

- 협회 명부나 개인 연락처를 협회 동의 없이 쓰거나, 동의 없는 광고성 정보를 보내지 마십시오.
- 환자에게 서비스 이용을 강요하거나, 다른 의료기관나 직역을 비방하지 마십시오.

협회 차원의 소개(세미나, 보수교육, 지회 행사 등)는 **대한의사협회의 동의와 협력을 전제로** 추진하며, 협의하는 대로 알려 드리겠습니다.

---

12. 런칭 계획 (제안)

컨소시엄은 **전국 규모로 시작**합니다. 참여 의료기관의 소재지에는 제한이 없습니다.

시기	내용
2026.10~12	사전 협의: 법률·회계 검토(주식 인수와 주주 간 계약, 선지급, GPL, 공정거래, 알선·광고, 증권 규제, 직역법), 직역 단체 협의, 전문가 면허 인증 연동 준비
주식 인수 협약	자본금 총액, 의료기관별 인수 주식, 요율, 선지급액과 정산 조건, 서버 구축 마일스톤을 확정하고 출자자에게 공개한 뒤 주주 간 계약과 정관을 확정합니다
법인 설립	주식 인수와 출자금 납입, 설립 등기를 거쳐 주식회사를 설립하고, 협약에 따라 나비웹에 선지급합니다
런칭	13장의 사전 조건을 마친 뒤 서비스를 시작합니다. **런칭 시기는 사전 협의가 끝나는 대로 확정해 알려 드립니다(미확정).** 기존 거래처 초대 방식으로 운영합니다
런칭 후	실측 결과를 정기적으로 주주에게 공개하고, 서버 구축 진행과 선지급 정산을 보고합니다

전국 규모로 시작하는 만큼, **13장의 사전 조건을 마치기 전에는 실제 업무에 연동하지 않습니다.** 또한 승인 한도와 승인 이력 기록(10장)을 처음부터 적용해, 의사가 실제로 검토할 수 있는 범위 안에서만 쓰이도록 합니다.

런칭 후 실측해 공개할 지표: 승인 이력 기록률, 승인 한도 준수, AI 초안을 의사가 수정한 비율, 업무당 처리 시간, SP의 지적·오판 건수, 서버 구축 진행률, 선지급 정산 내역, 법인의 수입·비용, 참여 의료기관 의견.

---

13. 현재 상태와 미확정 사항

미리 알려 드립니다. 아래가 정리되기 전에는 출자를 확정하거나 실제 업무에 연동하지 않습니다.

- **초안 단계**: 의사 페이지의 의료법·시행규칙 서식 번호·보존기간·감염병 신고 서식은 정리본(요약·해설 자료) 기준이며 법제처 원문과 대조하지 않았습니다.
- **면허 인증 미연동**: 현재 전문가용 AI를 면허로 인증해 제한하는 장치가 서버에 없습니다. 런칭 전에 연동을 마칩니다.
- **출자·로열티 금액**: 자본금 총액, 의료기관별 주식 인수액, 로열티 요율·이용료 체계, 1년치 추정 로열티 선지급액, 서버 구축 비용 중 분담 비율은 모두 **미확정**입니다.
- **법인 구조**: 주식회사로 설립합니다. 상호, 자본금, 주식 인수 한도, 의결·배당 방식, 주식 양도·회수 조건, 이사회 구성은 미확정입니다.
- **라이선스**: 나비웹의 소스는 GPL v3.0으로 공개되어 있어 로열티·이용료를 부과할 수 있는 범위를 법률 검토로 확인해야 하며, AI 모델의 바탕이 된 원 모델의 라이선스 조건도 확인해야 합니다.
- **주식 취득 제한**: 의사 개인과 의료기관 등 법인·기관이 이 주식회사의 주식을 취득하는 것에 대한 법령상 제한과 신고는 확인하지 못했습니다.
- **주식 발행 방식**: 청약 권유 대상의 수에 따른 증권 규제 적용 여부는 법률 검토가 필요합니다.
- **비영리 구조와의 정합**: 선지급·로열티 수령이 나비웹의 비영리 구조와 맞는지는 확인이 필요합니다.
- **법령 확인**: 의료법과 시행규칙의 서식 번호·보존기간·감염병 신고 서식은 법제처 원문과 대조하지 못했습니다. 서류 작성 전에 현행 서식과 조문을 조회합니다.

- **협약 내용**: 공정거래법·광고 규정·알선 규정·직역법 검토 결과에 따라 협약서가 바뀔 수 있습니다.
- **책임 분담**: 업무상 판단과 서명의 책임은 의사에게 있습니다. 소프트웨어 오류로 생긴 문제의 책임 분담은 협약서에서 정합니다(미확정).
- 이 도구는 AI이며 사람이 아닙니다. 법률·세무·회계·의료 자문이나 대리를 제공하지 않으며, 작성된 결과물은 의사가 검토·확정해야 합니다.

---

14. 자주 묻는 질문

나비가 의사의 일을 대신하나요? 아닙니다. 초안 작성과 점검을 돕는 도구이며, 진단·처방·치료와 그 판단, 문서의 확정과 서명은 의사가 합니다. 직원 계정도 승인 권한이 없습니다.

출자금은 얼마인가요? 미확정입니다. 총액과 의료기관별 출자는 7장의 산정 근거를 공개한 뒤 출자자가 의결로 확정합니다. 확정 전에는 출자를 요청하지 않습니다.

선지급한 로열티는 돌려받을 수 있나요? 선지급액은 사용량·매출에 따라 차감되고, 남는 금액의 이월·반환과 서버 구축 지연 시의 조정 조건은 협약서에 명시합니다(미확정). 확정되기 전에는 출자를 확정하지 않습니다.

출자하면 이익을 얻을 수 있나요? 이익은 보장되지 않으며 손실이 날 수도 있습니다. 이익이 생기면 보유 주식 수에 비례해 배당하는 것을 원칙으로 합니다.

손실이 나면 주주는 어디까지 책임지나요? 주주는 인수한 주식의 금액 한도에서만 책임을 집니다(유한책임). 다만 그 금액은 잃을 수 있습니다.

주식을 팔 수 있나요? 비상장 주식이라 팔기 어렵고, 양도는 정관에 따라 제한될 수 있습니다. 양도·회수 조건은 정관과 주주 간 계약에서 정합니다(미확정).

환자 데이터는 어디에 저장되나요? 이용자 본인의 데이터 금고(PDV)에 저장되고 서버에는 저장되지 않습니다. 의료기관은 이용자가 동의한 범위 안에서만 열람하며, 열람 이력이 남습니다. 다른 의료기관의 데이터는 볼 수 없습니다.

우리 의료기관의 환자와 진료 관련 대가가 다른 의료기관에 공개되나요? 아닙니다. 의료기관 간 환자·진료 관련 대가 정보는 교환하지 않으며, 데이터는 서로 격리됩니다.

동료를 소개하면 대가를 받나요? 받지 않습니다. 소개는 선택이며, 배당은 보유 주식 수에 비례할 뿐 소개 실적과 무관합니다.

중간에 그만둘 수 있나요? 주식 양도·회수 절차와 데이터 처리 방식은 정관과 주주 간 계약에서 정합니다(미확정).

---

15. 참여 절차와 문의

정식 문서(협약서, 정관, 주주 간 계약 등)는 **참여자가 확정된 뒤에 확정**합니다. 그 전까지는 이 제안서를 협의의 기초로 삼아 주십시오.

1. **설명 요청**: 이 제안서와 시연에 대한 설명을 요청해 주십시오.
2. **자격·소속 확인**: 면허·등록과 의료기관 정보를 확인합니다.
3. **협약서 검토**: 출자·로열티·선지급·서버 구축 조건이 담긴 협약서가 확정되면, 충분히 검토하신 뒤 결정하실 수 있습니다. 필요하면 변호사·회계사의 자문을 받으시기를 권합니다.
4. **출자 협약 체결**: 협약 체결 후 법인 설립과 선지급이 진행됩니다.
5. **서비스 시작**: 사전 조건을 마친 뒤 기존 환자 초대를 시작합니다.

문의: 나비 개발자 대표 도영민 · hondi.net

---

16. 관련 법령과 확인 수준

법령	이 제안과의 관계	확인 수준
의료법 제27조	무면허 의료행위 금지, 진단·처방의 판단과 책임은 의사에게 있음. 환자 유인·알선 관련 규정(제27조 제3항)은 확인 필요	정리본(요약·해설 자료) 기준이며 법제처 원문과 대조하지 않음
의료법 제33조	의료기관 개설 제한	정리본 기준
의료법 제19조·제21조	비밀 유지, 기록 열람 규정	정리본 기준. 확인 필요
개인정보 보호법	건강정보는 민감정보	일반 원칙 기준
소프트웨어 의료기기 관련 법령	진단·치료 목적의 소프트웨어는 의료기기 허가 대상이 될 수 있음	허가 필요 여부 확인 필요
상법 (주식회사)	설립, 주식 인수, 의결권, 배당, 이사회, 이사의 자기거래	일반 원칙 기준, 구체 조문 확인 필요
자본시장법	주식 발행 시 청약 권유와 증권신고	법률 검토 필요
GPL v3.0 (소프트웨어 라이선스)	소스 공개 소프트웨어에 대한 로열티·사용료 부과의 범위	법률 검토 필요

17. 면책 조항

1. **초안의 성격**: 본 문건은 협의를 위한 초안입니다. 계약의 청약이나 승낙, 주식 인수의 권유가 아니며, 이 문건만으로는 누구에게도 참여나 출자의 의무, 또는 나비 개발팀에 대한 어떤 권리도 생기지 않습니다. 권리와 의무는 정식 문서(협약서, 정관, 주주 간 계약 등)를 체결한 때에만 발생합니다.

2. **변경 가능성**: 본문의 구조, 일정, 금액, 요율, 요금, 기능, 참여 조건은 예고 없이 변경되거나 철회될 수 있습니다. 컨소시엄 참여자가 확정되지 않았거나 필요한 검토와 협의가 끝나지 않으면 이 제안은 진행되지 않을 수 있습니다.
3. **정보의 정확성**: 이 문건은 2026-10-18 기준으로, 공개된 법령·보도와 나비웹의 설계 자료를 바탕으로 작성했습니다. 확인하지 못한 사항은 본문에 표시했으나, 내용의 정확성과 완전성을 보장하지 않습니다. 법령은 개정될 수 있으므로 이용하시기 전에 최신 법령을 확인하십시오.
4. **설계 목표와 현재 기능**: 나비웹의 기능에 관한 설명은 설계 목표를 포함하며, 현재 구현된 기능과 다를 수 있습니다. 기능의 제공 시기와 범위는 변경될 수 있습니다.
5. **투자 판단**: 이 문건에는 수익·손실의 전망을 넣지 않았으며, 이익을 보장하지 않습니다. 출자할 경우 출자금의 전부 또는 일부를 잃을 수 있습니다. 출자 여부는 참여자 스스로 판단하시고, 결정 전에 변호사·세무사·공인회계사 등 독립적인 전문가의 자문을 받으시기 바랍니다.
6. **전문 자문이 아님**: 이 문건은 법률·세무·회계·의료·투자 자문이 아닙니다. 나비는 AI이며 사람 전문가를 대신하지 않습니다. 나비의 산출물은 의사가 검토·승인하기 전까지 초안·미확정이며, 업무상 판단과 서명의 책임은 해당 업무를 수행·승인한 의사에게 있습니다.
7. **단체 관련 언급**: 대한의사협회 등 단체의 언급은 협의 계획을 설명하기 위한 것이며, 해당 단체의 동의·승인·후원을 의미하지 않습니다.
8. **책임의 제한**: 나비 개발팀은 관련 법령이 허용하는 범위에서, 이 문건에 의존해 내린 결정으로 생긴 손해에 대해 책임을 지지 않습니다. 다만 법령상 제한할 수 없는 책임은 그러하지 않습니다.
9. **배포와 인용**: 이 문건은 협의 목적으로 제공됩니다. 정식 문서가 확정되기 전에는 외부 홍보 자료로 인용하거나 재배포하지 말아 주십시오.